

妊娠合併症1

耐糖能異常

血液凝固障害

甲状腺疾患

血液型不適合

TORCH症候群

産科婦人科 北折 珠央

2026年7月6日(月) 1限

＜自己紹介＞

三重県出身
名市大卒

趣味 旅行・映画

現在 産婦人科 講師
産科・MFICU病棟医長
周産期母子医療センター副センター長
無痛分娩センター副センター長
愛知県周産期協議会会長

家族：男子2人と金魚3匹と夫1人
夢：柴犬を飼うこと



耐糖能異常

糖尿病合併妊娠
と
妊娠糖尿病(GDM)

症例(妊娠糖尿病)

- ・ 38歳 1妊0産
- ・ 既往歴:特になし
- ・ 家族歴:母 2型糖尿病
- ・ 現病歴:自然妊娠成立し、妊婦健診を定期的に受診。胎児発育はやや大きめ、羊水量もやや多め。妊娠28週の健診で尿糖2+。妊娠糖尿病を疑い、75gOGTTで空腹時血糖90mg/dL,1時間値175mg/dL、2時間値160mg/dL。
- ・ 妊娠糖尿病の診断で、糖尿病内科にて食事指導・血糖管理を続けていたが高血糖が持続しインスリン療法開始
- ・ 39週1日陣痛発来し正常経膈分娩。児は3012g男児。児の生後1時間血糖値40mg/dLと低血糖を認め、ブドウ糖液を投与後改善
- ・ 産後は母体血糖もインスリンなしで問題なく生後5日で母児共に退院。



妊娠中の糖代謝

胎児に栄養を供給するため

妊娠中は、インスリン抵抗性は亢進
血糖値が上昇

する傾向にある

- ・空腹時飢餓亢進→空腹時血糖↓
ケトン体産生亢進
- ・食後の同化促進→食後血糖↑

糖尿病診断基準

	正常域	糖尿病域
空腹時値 75gOGTT 2時間値	<110 (6.1) <140 (7.8)	≥ 126 (7.0) ≥ 200 (11.1)
75gOGTTの判定	両者を満たすものを 正常型とする。	いずれかを満たすものを 糖尿病型*とする。
	正常型にも糖尿病型にも属さないものを境界型とする。	

*随時血糖値 ≥ 200 mg/dL (≥ 11.1 mmol/L) および
HbA1c $\geq 6.5\%$ (HbA1c (JDS) $\geq 6.1\%$) の場合も糖尿病型とみなす

正常型であっても、1時間値が180mg/dL (10.0mmol/L) 以上の場合には、180mg/dL未満のものに比べて糖尿病に悪化する危険が高いため、境界型に準じた取り扱い(経過観察など)が必要である。



妊娠中の耐糖能異常の診断基準

2010年7月改訂 日本糖尿病学会<http://www.jds.or.jp/>より

妊娠糖尿病 (GDM) : 妊娠中に初めて発見または発症した糖尿病に至らない糖代謝異常で、妊娠して診断された明らかな糖尿病は除外とする。

75gOGTTにおいて次の基準の**1点以上**を満たした場合に診断する。

- ・空腹時血糖値 ≥ 92 mg/dL (5.1mmol/l)
- ・1時間値 ≥ 180 mg/dL (10.0mmol/l)
- ・2時間値 ≥ 153 mg/dL (8.5mmol/l)

明らかな糖尿病 overt diabetes in pregnancy

以下のいずれかを満たした場合に診断する。

- ・空腹時血糖値 ≥ 126 mg/dL
- ・HbA1C (国際標準値) $\geq 6.5\%$ (HbA1C (JDS値) $\geq 6.1\%$) および
随時血糖値 > 200 mg/dL

*随時血糖値 > 200 mg/dLの時は、空腹時血糖かHbA1Cで確認

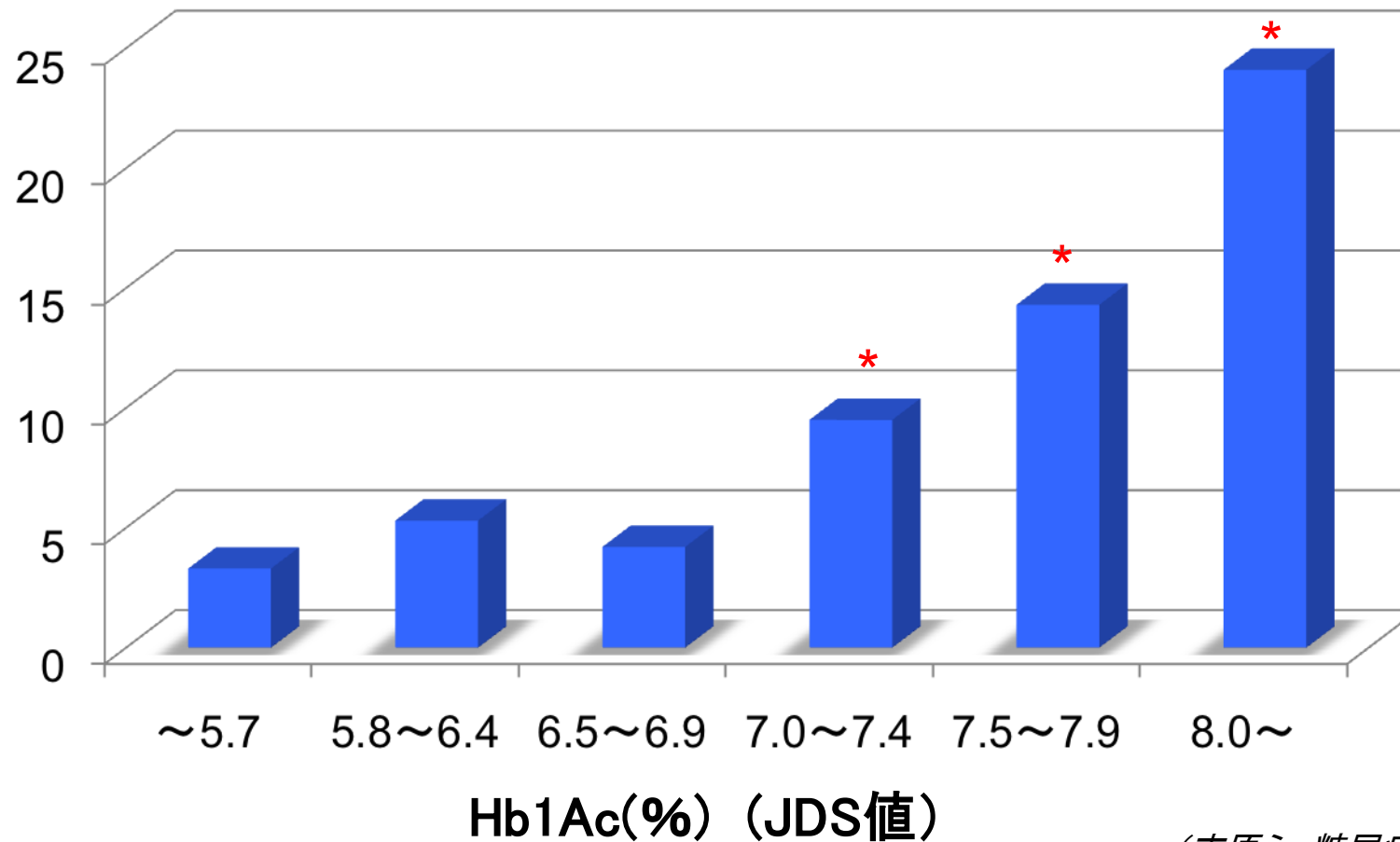
- ・糖尿病網膜症が存在する場合

妊娠初期のHbA1cと 児先天異常の頻度



児先天異常頻度 (%)

* $p < 0.001$ VS HbA1c 7.0%未満の群





糖代謝異常合併妊娠の母体合併症

1. 糖尿病合併症

糖尿病性ケトアシドーシス
糖尿病性網膜症の悪化
糖尿病性腎症の悪化
低血糖（インスリン使用時）

2. 産科合併症

流産
早産
妊娠高血圧症候群
羊水過多
巨大児にもとづく難産

3. 長期合併症

将来の2型糖尿病発症



糖代謝異常合併妊娠の**児**合併症

1. 周産期合併症

先天奇形、胎児死亡
胎児機能不全
子宮内胎児発育遅延
巨大児、肩甲難産に伴う
分娩障害
新生児低血糖
新生児高ビリルビン血症
新生児低カルシウム血症
新生児多血症
新生児呼吸窮迫症候群
肥厚性心筋症

2. 成長期合併症

肥満・糖尿病

神経管異常、腎形成異常、
心奇形、肺低形成、
消化管異常

糖尿病合併妊娠許容基準

1. 糖尿病性網膜症

単純網膜症：妊娠前に血糖値がコントロールされている

増殖網膜症：妊娠前の良好な血糖コントロールに加えて、光凝固法などの治療をおこない、網膜症が沈静化した後

2. 糖尿病性腎症

腎機能が保たれている($\text{Ccr} > 60\text{ml/分}$)場合

糖尿病腎症を発症すると腎機能は進行性に悪化するので糖尿病女性の場合は腎症発症以前のなるべく早期の妊娠を勧める



糖代謝異常合併妊娠中の母体管理

経口血糖降下薬は妊婦には禁忌

目標血糖値 食前値: 70~100mg/dl
食後2時間値: 120mg/dl以下

食事療法: 4~6分割食とする
非妊時標準体重 × 30kcal/kg
妊娠中+200kcal(肥満者*+0kcal)、
授乳期+450kcal(肥満者*+200kcal) (*肥満者はBMI25以上)

血糖値自己測定4~7回/日(毎食前・毎食後2時間・就寝前)とし目標値を達成できない場合は**インスリン療法**(中間型または超速効・速効型)をおこなう。

GDM再発および糖尿病発症の予知因子

妊娠時の耐糖能の程度
分娩直後の耐糖能の程度
妊娠時のインスリン必要症例
妊娠時のより早い時期の診断
家族歴糖尿病あり
GDMの既往
妊娠前の肥満
母体高齢
妊娠時および産後の体重増加
巨大児分娩既往
人種(白人以外)

血液凝固障害

血液検査上の変化

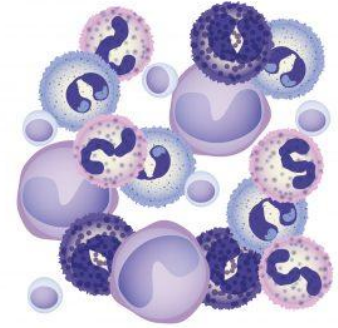
白血球数 増加 (6000~15000/mm³)

赤血球数 約1.2倍

血漿量 約1.5倍

→水血症で見かけ上の貧血

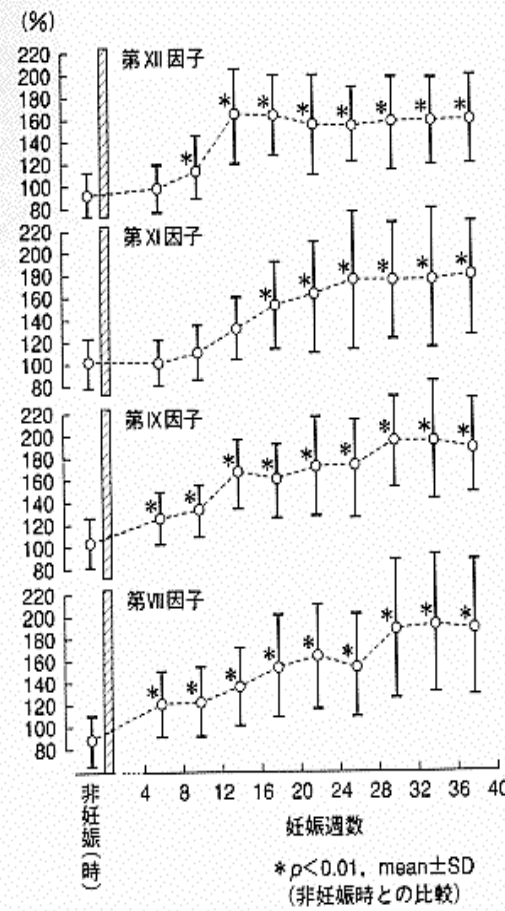
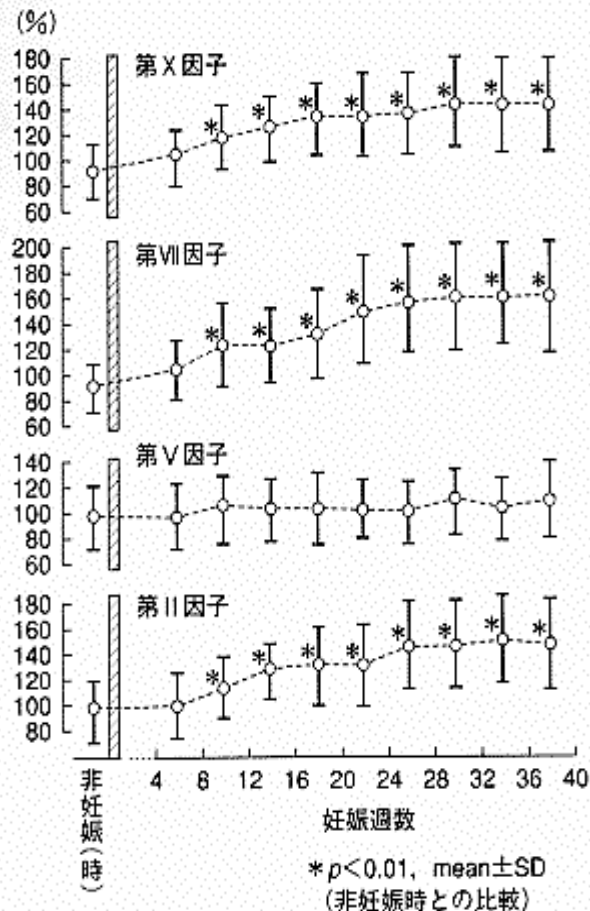
鉄の需要量 増加(1.5倍) 鉄欠乏性貧血
葉酸需要増加により葉酸欠乏性貧血にも。



凝固系の変化



凝固系活性化 線溶系活性は軽度のみ
血液凝固因子増加 血小板不変～低下



各種凝固因子は週数とともに増加傾向

Protein S (凝固抑制因子)は低下する

→凝固亢進へ傾く

→血栓症を起こしやすい

妊娠中の凝固因子

表1 妊娠経過に伴う血液凝固因子活性の変化（文献2より引用して作成）

凝固因子活性 (%)	非妊女性	妊娠4週～	8週～	12週～	16週～	20週～	24週～	28週～	32週～	36～40週
XII	92±20	96±21	116±34*	161±42*	160±36*	151±44*	153±33*	150±41*	151±39*	151±40*
IX	104±21	126±20*	131±21*	162±29*	151±31*	166±42*	165±41*	186±40*	185±52*	180±41*
VIII	88±22	121±29*	122±30*	135±34*	151±44*	159±46*	150±44*	182±61*	185±61*	181±60*
VII	91±20	104±25	124±34*	123±32*	130±35*	148±42*	155±41*	159±41*	160±38*	158±42*
X	91±21	101±21	117±23*	123±25*	130±28*	132±30*	132±31*	140±34*	138±36*	139±33*
V	95±24	95±24	101±26	99±25	100±28	98±23	95±23	105±25	98±24	105±30
II (プロトロンビン)	96±24	99±24	113±23*	125±21*	129±30*	130±31*	144±33*	143±32*	148±33*	144±35*
XIII	94±15	96±15	94±11	93±11	83±11*	80±10*	75±13*	47±11*	74±12*	70±13*
I (フィブリノゲン) (mg/dl)	256±79	300±130*	310±70*	355±85*	358±53*	345±55*	387±68*	405±65*	417±82*	440±80*

*: P<0.01 vs. 非妊女性

2) 真木正博, 設楽芳宏: 産婦人科領域における血栓症, 日本臨牀44: 1178-1186, 1986.

表2 妊娠中の凝固線溶系マーカーの推移（文献3より引用して作成）

	FMC (μg/ml)	TAT (ng/ml)	Dダイマー (μg/ml)	FDP (μg/ml)	フィブリノゲン (mg/dl)	PIC (μg/ml)	PT (%)	APTT (秒)
妊娠初期 (11-15週) n=33								
平均	3.35	2.3	0.43	1.94	399	0.5	99	35.1
25th-75thパーセンタイル	2.74-3.95	1.7-3.2	0.28-0.57	1.59-2.25	333-459	0.4-0.6	93-100	32.7-37.9
範囲	0.91-8.14	0.9-8.8	0.22-1.64	1.26-3.06	249-679	0.2-0.8	79-110	30.3-50.3
妊娠中期 (16-27週) n=15								
平均	3.35	3.7**	0.59*	2.59*	424	0.4	100	35
25th-75thパーセンタイル	2.74-3.95	3.1-4.3	0.39-0.72	2.09-2.89	374-463	0.3-0.5	93-100	32.3-38.0
範囲	1.52-5.16	1.6-8.2	0.28-0.85	1.10-3.39	298-606	0.2-0.7	90-112	30.5-45.5
妊娠後期 (28-42週) n=39								
平均	3.95*	6.5**	0.91**	3.73**	456**	0.4	100*	33.5
25th-75thパーセンタイル	2.74-5.16	4.3-9.8	0.57-1.52	2.59-4.61	406-517	0.3-0.5	100-101	32.1-37.0
範囲	1.52-19.5	1.8-13.8	0.33-3.90	1.76-13.1	345-668	0.3-1.4	92-114	28.2-38.7

Mann-Whitney U test, *: p <0.05, **: p <0.01 (妊娠初期に対する有意差)

FMC: fibrin monomer complex, TAT: thrombin antithrombin complex, FDP: fibrin degradation product, PIC: plasmin inhibitor complex, PT: prothrombin time, APTT:

FMC, Dダイマー, FDPはlatex immunoassay, TAT, PICはenzyme immunoassay

静脈血栓血栓症(VTE)



妊娠中は深部静脈血栓症(DVT)を発症しやすい(**非妊時の5倍**)

- ・血液凝固能の亢進と線溶能の低下
- ・血小板の活性化
- ・女性ホルモンの静脈平滑筋弛緩作用、
- ・増大した妊娠子宮による腸骨静脈や下大静脈の機械的圧迫

肺血栓塞栓症(pulmonary thromboembolism:PTE)

- ・経膣分娩後の0.003%
- ・帝王切開後の0.06%（経膣の10~20倍！）

近年低下傾向はあるが死亡率は約20%と高率

DVTとPTEは一連の病態であり静脈血栓塞栓症(VTE)と総称する

帝王切開術は「妊娠中」に「骨盤内の手術」→術後VTE発症は高率
悪阻の時期も脱水により発症しやすい。

血栓症その1

症例

31歳女性、3経妊0経産。

自然妊娠成立、妊娠8週頃より悪阻により水分・食事の摂取量が低下し自宅安静していた。

妊娠10週で左下肢の腫れと痛みがあり受診。

左下腿に腫脹、発赤、把握痛があり、血液検査でDDダイマー $20\mu\text{g/mL}$ と上昇。下肢静脈エコーで血栓を認めた。

ヘパリン持続点滴開始、14日後に血栓が消失し、ヘパリンカルシウム自己皮下注射に切り替え、退院した。

ヘパリン投与は継続、39週で陣痛発来しヘパリン中止し、経膣分娩。

血栓症その2

症例

40歳女性、1経妊0経産。妊娠経過に異常認めず。
40週3日、陣痛発来で入院。微弱陣痛で促進するも分娩進行せず、
陣痛発来から32時間で分娩停止で帝王切開。

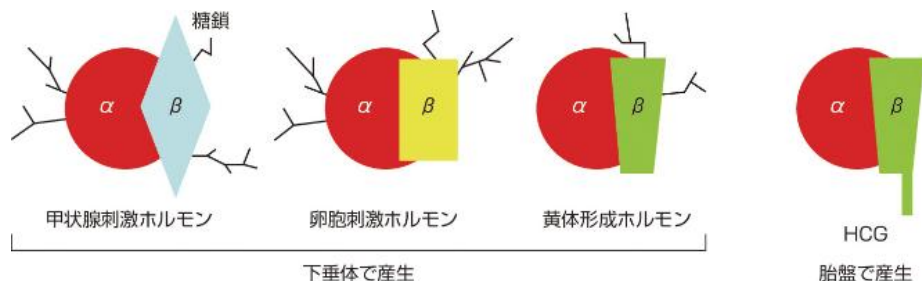
術後1日の午後、トイレ歩行時に突然の強い胸痛と呼吸苦が出現。
血圧79/51mmHg、心拍数120bpm、SpO2 80%台。
胸部CTにて左下肺動脈内に血栓を認めた。
肺血栓塞栓症の診断でヘパリン投与開始。
その後徐々に安定しワーファリン内服へ移行し退院。

甲状腺疾患

妊娠中の甲状腺関連ホルモンの推移

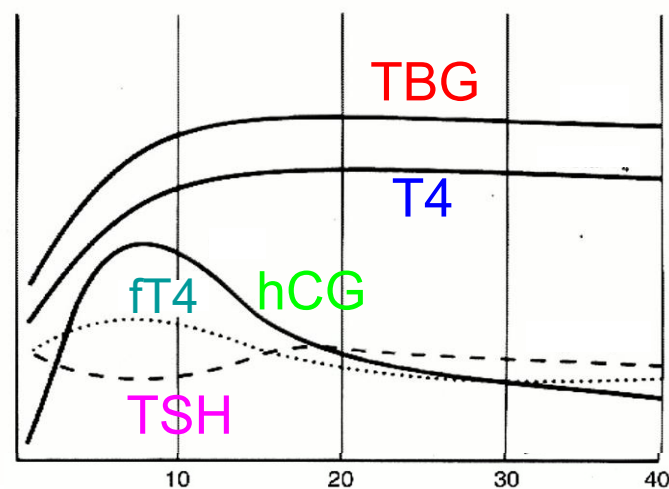


TSHとhCGは共通の構造を持ち、hCGは弱いTSH作用がある



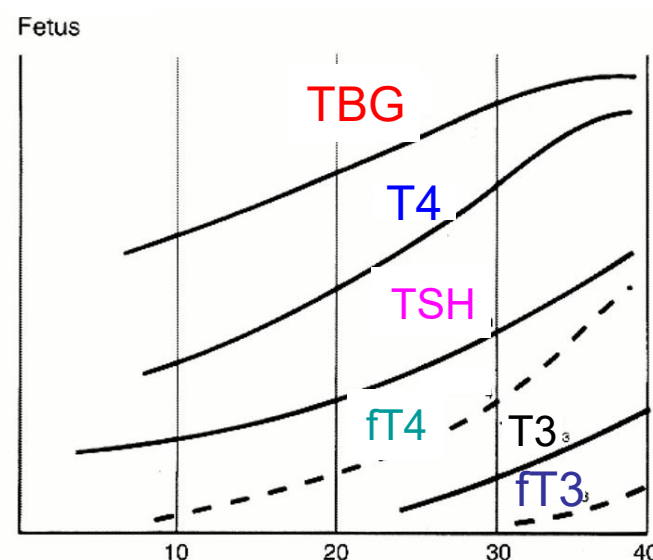
©図15-2-4 TSH, LH, FSH, HCGの基本的構造 (Goodman HM: Basic Medical Endocrinology (4th ed), 2009より作成)
これらの糖鎖を伴うα-サブユニットとβ-サブユニットからなる。α-サブユニット部分はLH, FSHおよびhCG (human chorionic gonadotropin) と共通であるが、β-サブユニット部分はそれぞれのホルモンで特異的である。

母体
Mother

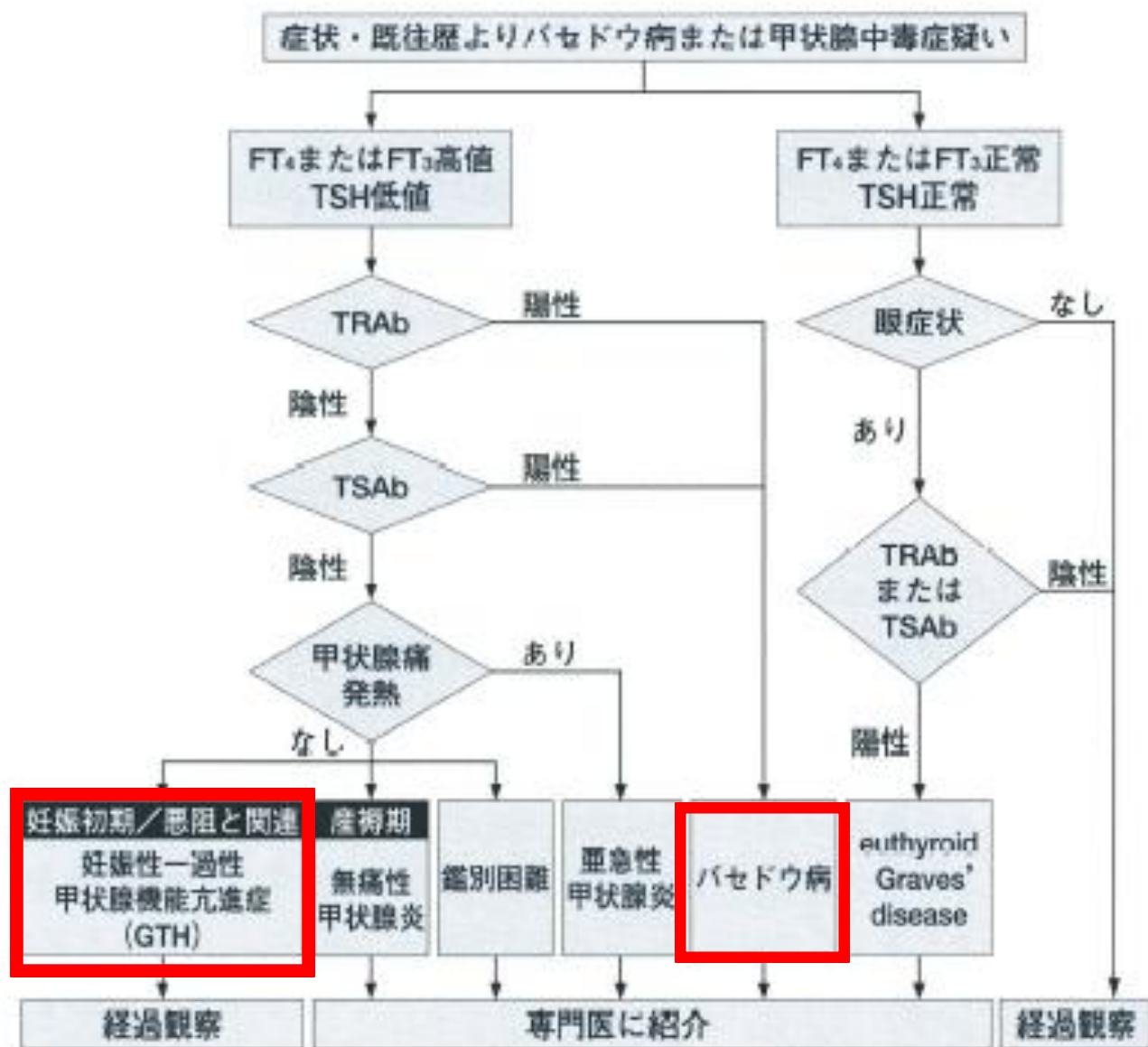


妊娠週数

胎児
Fetus



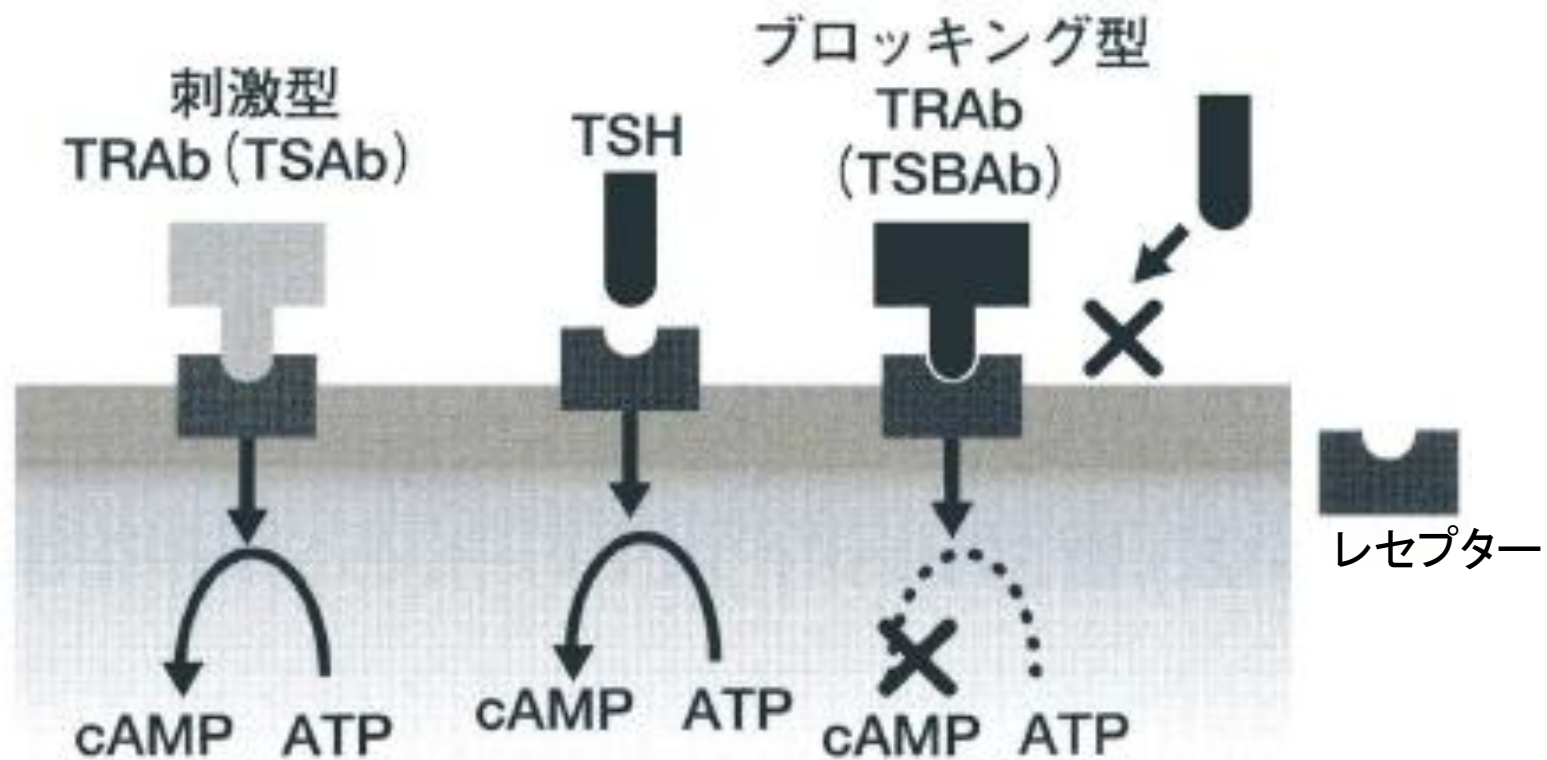
妊娠週数



妊娠・産褥での甲状腺疾患の鑑別

TSH受容体抗体(TRAb)の種類

TSH受容体抗体(IgG)は胎盤通過性あり



バセドウ病合併妊娠

母体に関する影響

1. 流早産、死産、子宮内胎児発育遅延、
妊娠高血圧症候群
2. バセドウ病の悪化：頻脈・不整脈、発熱、
甲状腺クリーゼ
3. 抗甲状腺薬の副作用：無顆粒球症、肝障害など

胎児・新生児に関する影響

1. 甲状腺刺激活性のある自己抗体の経胎盤的移行
→ 胎児・新生児甲状腺機能亢進症
2. 不適切な抗甲状腺薬の投与（過剰投与）
→ 胎児・新生児甲状腺機能低下症



バセドウ病合併妊娠の管理

1. 専門医との連携が可能な環境にあること
2. 甲状腺機能が正常範囲内にあり、病勢が安定していること
3. 妊娠を希望する場合にはPTU(プロピルチオウラシル)を選択する。MMI(メチマゾール)内服中では可能であればPTUに変更する。
4. 放射性ヨード治療後、6ヶ月以上してから妊娠とすること
5. 甲状腺手術後や放射性ヨード治療後は甲状腺機能低下症に注意

甲状腺機能低下症

- ・**原発性甲状腺機能低下症:**

慢性甲状腺炎・橋本病

放射性ヨード治療後や甲状腺切除後低下症

抗マイクログロブリン(抗TPO)抗体陽性

抗サイログロブリン抗体陽性

阻害型抗TSH抗体による発症の場合あり

- ・**中枢性甲状腺機能低下症:**

下垂体・視床下部疾患による

下垂体ホルモン分泌試験にて診断



甲状腺機能低下症合併妊娠

妊娠・分娩に対する影響

1. 初期流産率が上昇

2. 妊娠高血圧症候群、早産、常位胎盤早期剥離、
子宮内胎児発育遅延、児の精神発達遅延、分娩
後出血などのリスク増加

※甲状腺機能低下症の場合、一般的に妊娠すると
T4補充量を増加する必要がある。

血液型不適合

血液型不適合妊娠

母体がもたない赤血球型抗原を児がもっている妊娠
→厳密にはほぼすべての妊娠が「血液型不適合」

実際には母体血中に不規則抗体(抗A抗B以外)を生じたものをいう。

過去及び現在の妊娠・分娩中に経胎盤に母体に流入した児の赤血球により母体が感作

→生じた抗体のうちIgGは胎盤を通過し児へ抗体が移行

→児の体内で免疫反応→溶血

=**胎児新生児溶血性疾患**(hemolytic disease of the fetus and newborn: HDFN)



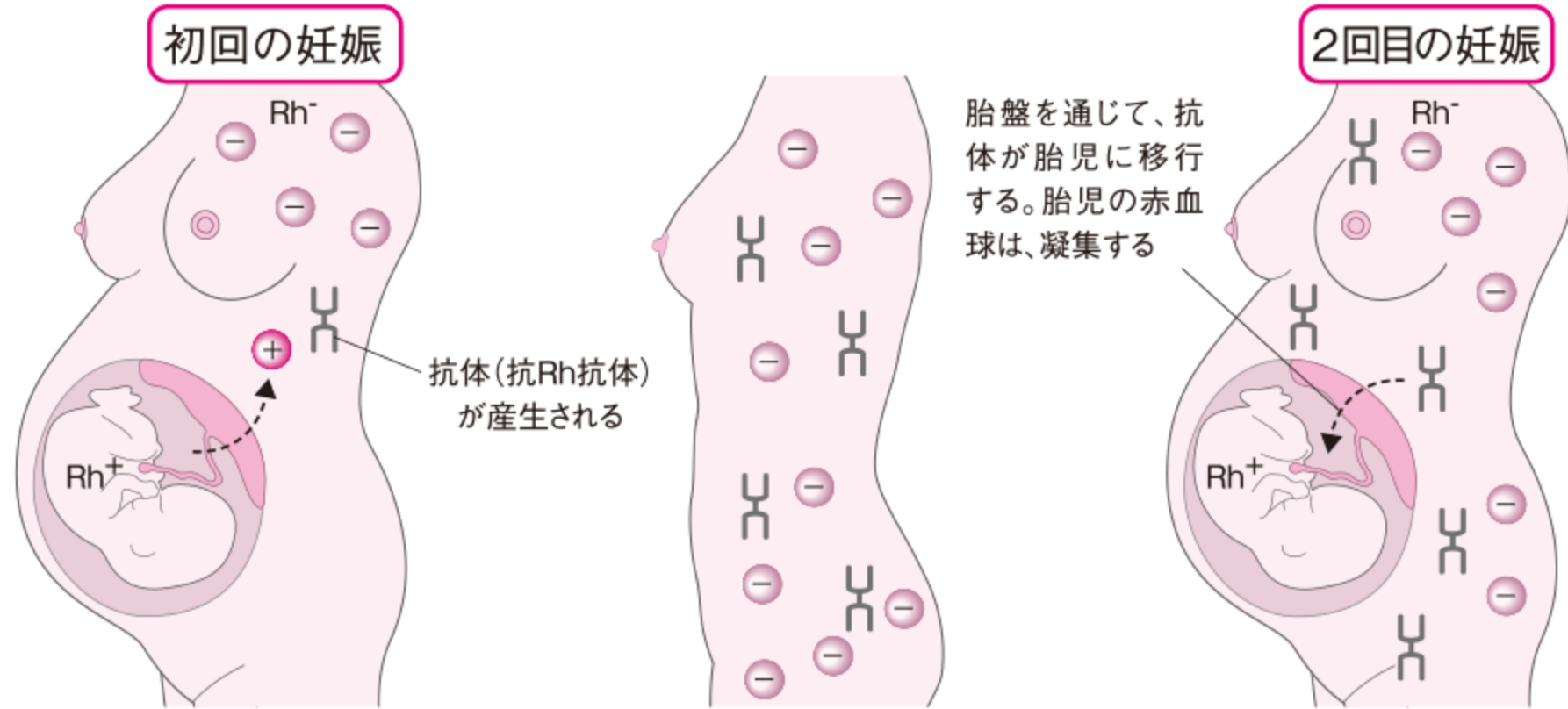
血液型不適合妊娠

- ・血液型不適合の病態生理

胎児赤血球は母体循環に流入する

妊娠初期から見られ、**分娩時が最大の流入の機会**
(流産や異所性妊娠、妊娠中の腹部外傷、胎盤早期剥離、羊水穿刺
などでも流入するリスクあり)

(何も対応しないと)1回目の妊娠中・分娩時に感作され、母体に抗体がつくられる(第一子自体は問題なし)、**第二子妊娠中に抗体(IgG)が胎盤を通過し、胎児赤血球と抗原抗体反応して溶血し、胎児水腫や新生児溶血性疾患を起こす。**



血液型がRh(-)の女性とRh(+)の男性との間で妊娠が成立すると、Rh(+)はRh(-)に対して優性となるため、胎児の血液型はRh(+)となる。この胎児のRh(+)抗原は、胎盤を通じて母胎の血液中に移行すると、母胎内では抗Rh抗体(凝集素)が産生される。

しかし、初回の妊娠では産生される抗体が少ないため、胎盤を通じて抗体が胎児に入っても、赤血球を凝集させるまでには至らない。母胎では抗体が産生され続けるため、2回目の妊娠では胎児の赤血球は母親の抗体によって凝集され、溶血を起こす。



1) Rh不適合

Rh式血液型抗原の代表的なものは、D,C,c,E,eの5種類

D>>E>C>c>eの順に免疫原生が高い

いわゆるRh- = RhD陰性は日本人では0.5%

RhD陰性妊婦に対しての感作の予防が主な治療

→抗Dグロブリンを①28週頃と②分娩時 に母体に投与する

2) ABO不適合

HDFNはほとんどの場合母体がO型でおきる

3) その他

抗RhEや抗Le^aなど

母子感染症



TORCH症候群

T: Toxoplasma トキソプラズマ

O: Others: その他（梅毒、B型肝炎、
水痘・带状疱疹ウイルス等）

R: Rubella（風疹）

C: Cytomegalovirus（サイトメガロウイルス）

H: Herpes simplex virus（単純ヘルペス）

胎内感染で肝脾腫、黄疸、肺炎、紫斑、脈絡網
膜炎などが共通してみられる

表3-30 母子感染の感染経路

A から E は重要度を示す

		胎内感染	分娩時感染	母乳感染
ウイルス	風疹ウイルス	A	E	E
	サイトメガロウイルス	A	A	A
	パルボウイルス B19	A	E	E
	水痘・帯状疱疹ウイルス	B	A	E
	単純ヘルペスウイルス	B	A	E
	コクサッキーウイルス	C	E	E
	B 型肝炎ウイルス	D	A	E
	C 型肝炎ウイルス	D	B	E
	ATL ウイルス (HTLV-1)	D	D	A
	エイズウイルス (HIV)	D	A	B
クラミジア	クラミジア・トラコマチス	E	A	E
細菌	梅毒 (トレポネーマ・パリドウム)	A	A	E
	淋菌	E	A	E
	B 群溶連菌 (GBS)	E	A	E
真菌	カンジダ・アルビカンズ	D	A	E
原虫	トキソプラズマ・ゴンディ	A	E	E

(川名 尚より)

表3-31 胎内感染によって出現する症状 (TORCH 症候群)

症 状	感染病原体				
	風疹ウイルス	サイトメガロウイルス	単純ヘルペスウイルス	トキソプラズマ・ゴンディ	トレポネーマ・パリドウム
肝脾腫	+	+	+	+	+
黄 疸	+	+	+	+	+
肺 炎	+	+	+	+	+
紫 斑	+	+	+	+	+
脳脊髄膜炎	+	+	+	+	+
脈絡網膜炎	++	+	+	++	+
小頭症	-	++	+	+	-
脳内石灰化	-	++	+	++	-
水頭症	+	-	+	++	-
難 聴	+	++	-	-	+
白内障	++	-	+	+	-
角膜結膜炎	-	-	++	-	-
心筋炎	+	-	+	+	-
心奇形	++	-	-	-	-
骨の異常	++	-	-	+	++
皮膚水泡	-	-	++	-	+
発 疹	-	-	+	+	++

(++) は特徴的な症状

(Klein Jo, 2006 より)

風疹

Rubella



MR(麻疹・風疹)ワクチン接種で大流行は減ったが
周期的に流行をみせる感染症(主に小児)
国をあげての抗体検査・ワクチン接種により、最近は感染は抑えられている
(2025年9月にWHOは日本は風疹排除状態と認定)

先天性風疹症候群 (congenital rubella syndrome; CRS)

妊娠5か月までに妊婦が風疹罹患すると

胎児は

心奇形

白内障

難聴

を3主徴とするCRSを発症

表3-34 妊娠中風疹感染の時期と先天異常の出現頻度

	風疹に罹患した妊娠月数 (%)				
	第1月	2 月	3 月	4 月	5月以降
心疾患	34 (29.3)	62 (53.5)	17 (14.7)	2 (1.7)	1 (0.9)
白(緑)内障	30 (44.8)	31 (46.3)	6 (9.0)	0	0
聴力障害	50 (24.8)	76 (37.6)	55 (27.2)	21 (10.4)	0
発達障害 (神経系障害)	34 (26.6)	63 (49.2)	20 (15.6)	11 (8.6)	0
新生児期 紫斑病	14 (21.2)	43 (65.1)	7 (10.6)	2 (3.0)	0

全妊婦に対してスクリーニングとして風疹抗体検査を行う

風疹抗体が陽性の場合、妊娠前の感染か、妊娠のどの時期に感染したのか時期の推定が重要
(安易に中絶がされないように)

妊娠初期に抗体がない(低い)ことがわかってても妊娠中にワクチンは打てないため、予防に努める。(産後にワクチン接種推奨)

図3-36 風疹感染のウイルス排泄と抗体反応

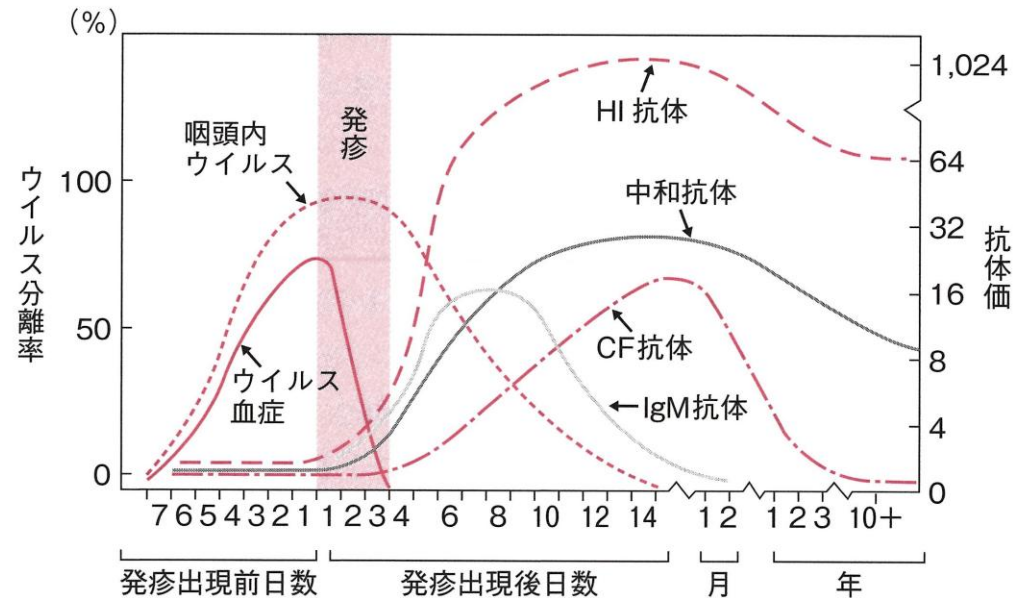
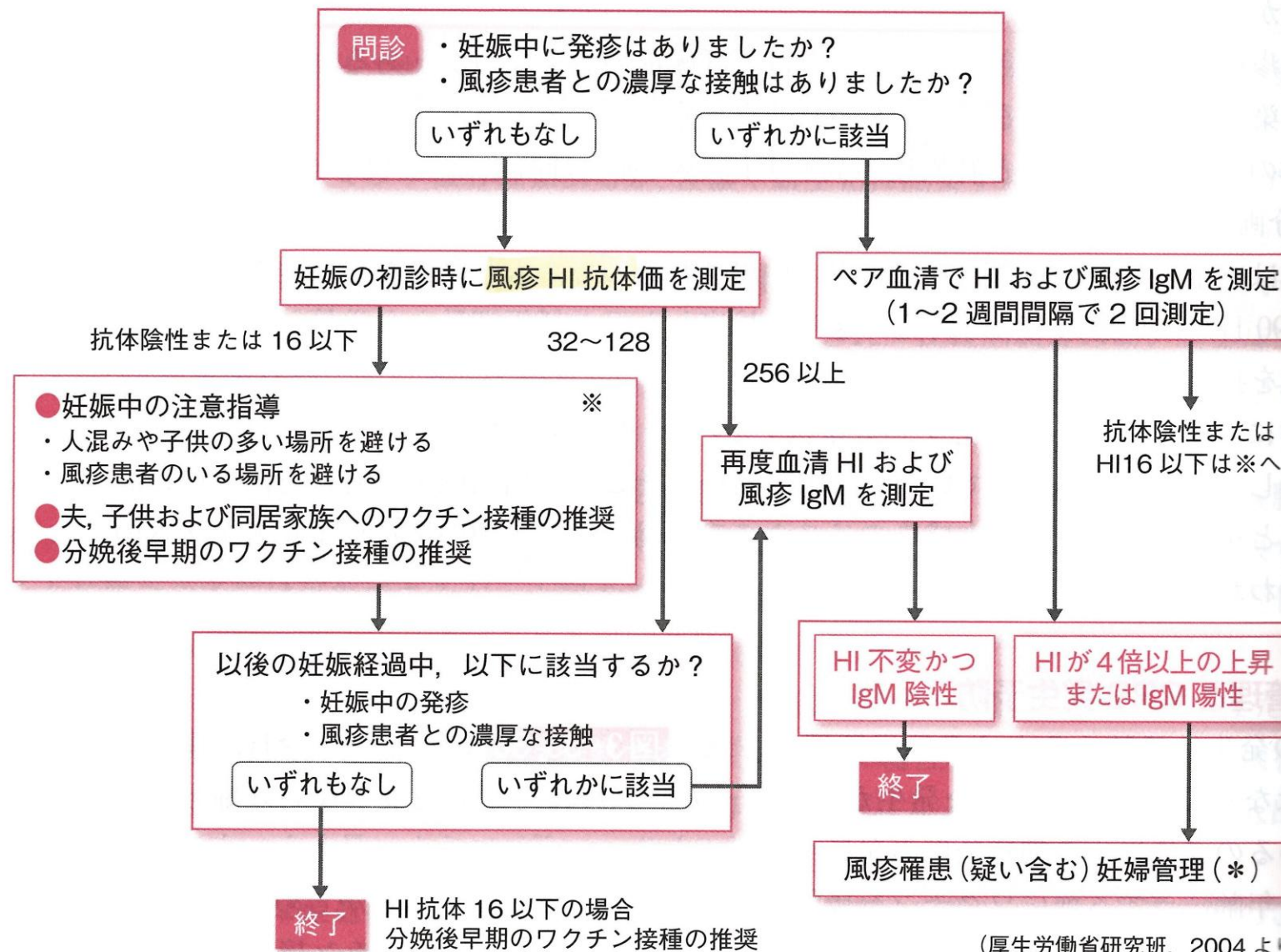




図3-35 妊娠女性への対応診療指針



梅毒

treponema pallidum



経胎盤感染

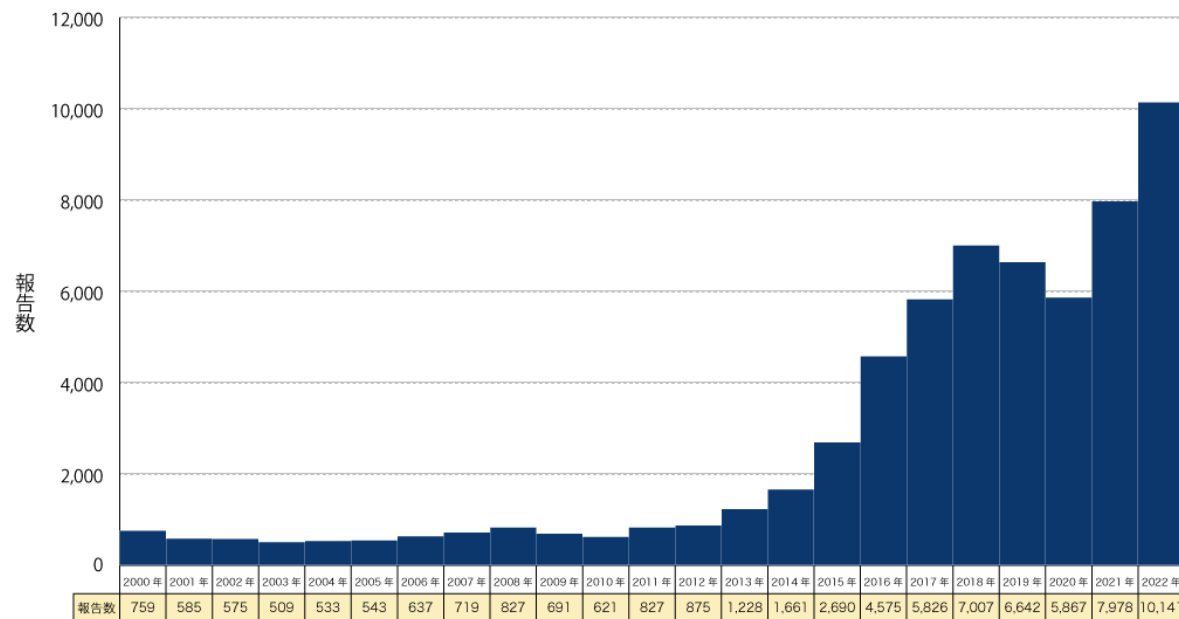
妊娠初期に全妊婦にスクリーニングとして梅毒血清検査が行われている(STS, TPHA)

2003年以降は新規梅毒患者が急増しており、先天性梅毒も年間数例の報告あり

胎児先天梅毒: 肝腫大、胎児水腫、腹水、胎盤肥厚、
子宮内胎児死亡など

治療: ペニシリン系、マクロライド系

図 1. 感染症発生動向調査における梅毒報告数、診断年別 2000～2022 年（2022 年は第 1～42 週）



※2020 年までは年報確定データ、2021 年以降は第 42 週週報集計時点（2022 年 10 月 26 日）

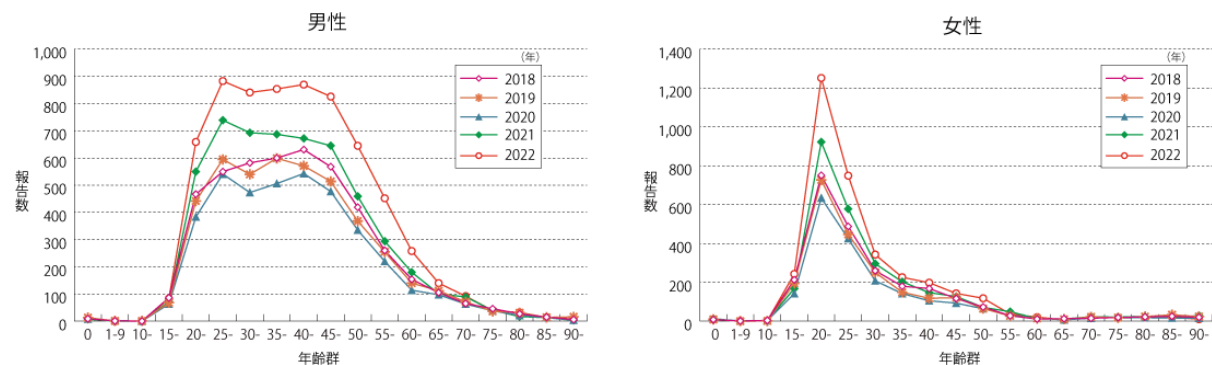
梅毒患者数は急増！

患者の 1/3 は女性

女性の梅毒患者は20代が最多

先天梅毒の増加が懸念

図 2. 感染症発生動向調査における梅毒報告数、年齢群別 2018～2022 年（2022 年は第 1～42 週）



※2020 年までは年報確定データ、2021 年以降は第 42 週週報集計時点（2022 年 10 月 26 日）

妊娠初期にスクリーニングし、
早期発見・治療が大事

トキソプラズマ

toxoplasma gondii; TG



トキソプラズマ: という原虫による人畜共通感染症

最終宿主: ネコ

中間宿主: ブタ、ウシ、ヒツジ、ヒトなどの哺乳類、鳥類

ヒトへの感染経路: ネコの糞便、生の食肉に経口感染が主
(生肉、加熱の弱い肉、汚染の可能性ある生野菜、
ガーデニングや砂場での接触)

先天性トキソプラズマ症: 妊娠中の初感染による
脈絡網膜炎、水頭症、精神運動障害

妊娠初期は胎内感染は低いが重症、
妊娠末期では感染率が高いが影響は小さい

母体へのスピラマイシン投与で出生児の障害が減らせる

B群連鎖球菌

group B streptococcus (GBS)



新生児の敗血症、肺炎、髄膜炎などの重症感染症の起炎菌
5000～20000出生に1例程度
早発型は致死率高い

分娩時に産道で感染

GBSは一般妊婦の10～30%で検出される常在菌
児に感染を起こすものはごく一部

妊娠後期にGBS培養検査を行い、陽性妊婦には分娩時に
ペニシリン系抗菌薬を投与し、母子感染を予防する

サイトメガロウイルス

cytomegalovirus; CMV



最近先天性CMV感染症児が増加、
難聴児の15%がCMVの胎内感染

若い女性のCMV未感染者: 30~40年前は5%
最近は20~30%と増加

妊娠中に初感染する妊婦が増加
(1~2歳児の尿や唾液から感染しやすい)

先天性CMV感染の大部分は無症候性
発症すると、脈絡網膜炎、黄疸、肝脾腫、紫斑
小頭症、脳内石灰化
先天的に難聴のある児にCMV感染が多く報告されている。

初感染の診断には母体IgM抗体、羊水中や胎児血のCMV-PCR



単純ヘルペス

herpes simplex virus: HSV

1型(口、目) 2型(性器)

HSVに対する治療薬のアシクロビル、バラシクロビルは
胎児毒性がほとんどないため、性器ヘルペス合併妊婦には全身
投与を行う

胎内感染はごくまれ

産道感染による新生児ヘルペスは予後不良
全身型では30%死亡

分娩時に外陰部ヘルペス発症していると50%に新生児ヘルペス
→分娩は帝王切開

水痘・帯状疱疹

varicella zoster virus; VZV

妊娠中の水痘罹患：先天性水痘症候群
新生児水痘

水痘罹患の週数によるが先天性水痘発生率は
20週未満の感染0.4~2.0%
21週以降は0%

皮膚瘢痕性病変、目の異常、四肢低形成、低出生体重児、精神発達障害

帯状疱疹は児への影響は0%と報告あり

ヒトT細胞白血病ウイルス1型

Human T cell leukemia virus type I (HTV-1)



成人T細胞白血病adult T-cell leukemia: ATLの原因となるウイルス

HTLV-1キャリア1000人に1人の割合で40歳以降にATL発症
生涯発症率は5%、大部分は死に至る

日本では九州・四国・沖縄を中心とする西日本に多く分布
(キャリア頻度は九州地区は東日本地区に比べて5~10倍高い)

感染経路は主に母乳

HTLV-1は全妊婦にスクリーニング検査をし
陽性の場合必ず確認検査を行って診断を確定する
診断された場合は人工栄養が勧められている

表3-42 妊婦における HTLV-1 キャリア率

地 域	キャリア率	報告書
宮 崎	5.5%	森 憲正
鹿児島	5.5%	園田俊郎
鹿児島	4.7%	武 弘道
静 岡	0.33%	川島吉良
東 京	0.3%	本多 洋
東 京	0.8%	柳田昌彦
北海道	9.6%	千葉峻三

表3-43 HTLV-1 母子感染の疫学

	陽性者 / 対象者	キャリア率 (%)
キャリア母から出生した児 (1~13 歳)	38/245	15.5
学童 (6~12 歳)	4/397	1.0
キャリア児の母	12/13	92
キャリア妊婦の母	15/17	88

表3-44 母乳哺育児と人口栄養児の母子間感染率—抗体検査による—

報告者	年 度	抗体検査法	母乳栄養群		人口栄養群	
			陽性者 / 全児	キャリア発生率	陽性者 / 全児	キャリア発生率
一條元彦	1988	PA-EIA	13/31	41.9%	0/30	0 %
伊藤忠一	1991	PA-EIA	9/30	30.0%	2/48	4.2%
辻 芽郎	1991	PA-IF	22/90	24.4%	4/140	2.9%
嶽崎俊郎	1991	PA-IF	26/231	11.3%	5/143	3.5%
前浜俊之	1992	EIA-WB	10/165	6.1%	0/46	0 %
武 弘道	1993	PA-EIA	23/161	14.3%	2/71	2.8%
園田俊郎	1993	PA-IF	5/58	8.6%	15/233	6.4%

パルボウイルスB19感染症



パルボウイルスB19感染症→りんご病(伝染性紅斑)

2025年は全国的な流行

潜伏期間が10~20日と長く
発疹がでる7~10日前がウイルス排出が
最も多く、頬に発疹が出るころには感染力はほぼない



日本人妊婦の抗体保有率は20~50%
妊婦が初めて感染すると2割が胎盤を介して胎児に感染
胎児感染の2割が流死産や胎児貧血、胎児水腫を起こす

大人は感染しても症状が乏しいため接触歴の有無が重要